

UNIDAD 1. 2

ÍNDICE.

1. **Luciani Conde, L.** (2020) “El trabajo de las disciplinas y la igualdad de derechos como núcleos problemáticos”.
2. **Luciani Conde, L.** (2021) “Por una matriz formativa alternativa en Salud Mental: Aportes de los estudios decoloniales al campo de la salud Mental Colectiva / Medicina Social Latinoamericana. Salud Mental y Comunidad”.
3. **Stolkiner, A.** “Derechos Humanos y Salud desde el Pensamiento Médico Social / Salud Colectiva Latinoamericano”.
4. **Ley 26.657**, Ley Nacional de Salud Mental. Derecho a la Protección de la Salud Mental. **Decreto Reglamentario 603/2013, Capítulos I – IV.**
Recuperado el 27 de octubre de 2015.

UNIDAD 1. 3

ÍNDICE.

5. **Stolkiner, A.** “Las formas de transitar la adolescencia hoy y la salud / salud mental: actores y escenarios”.
6. **Stolkiner, A.** “Medicalización de la vida”.
7. **Stolkiner, A.** “Subjetividades de época y prácticas de Salud Mental”.
8. **Stolkiner, A.** “Tiempos posmodernos: Procesos de ajuste y salud mental”.
9. **Stolkiner, A., Ferreyra, J.** “Psicopatologizar la cuarentena”.

UNIDAD 1. 4

ÍNDICE.

10. **Elichiry, N.** “La importancia de la articulación interdisciplinaria para el desarrollo de metodologías transdisciplinarias para el desarrollo de metodologías transdisciplinarias”.
11. **García, R.** “Dialéctica de la integración en la investigación interdisciplinaria”.
12. **Stolkiner, A.** “De interdisciplinas e indisciplinas”.
13. **Stolkiner, A.** “Enfoque interdisciplinario en el campo de la salud”.
14. **Ley 26.657**, Ley Nacional de Salud Mental. Derecho a la Protección de la Salud Mental. **Decreto Reglamentario 603/2013, Capítulo V.**
15. **Tajer, D., Luciani Conde (...).** “Estado, políticas sociales, salud colectiva y salud mental.”
16. **Wagner de Sousa Campos.** “Desafío epistemológico y práctico: Cómo reformular, ampliando e integrando, la clínica y la salud colectiva (en Método Paideia: análisis y cogestión de colectivos, pp. 184-206.”

U1.02. Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

01. **Luciani Conde, L.** (2020) "El trabajo de las disciplinas y la igualdad de derechos como núcleos problemáticos"

RESUMEN DETALLADO.

La atención en salud mental en Argentina se encuentra actualmente en una encrucijada crítica entre los compromisos estatales asumidos para adecuarse a un enfoque de derechos humanos y un modelo operativo que pervive reproduciendo prácticas violatorias de esos mismos derechos. El origen de esta tensión reside en que la práctica en salud mental no ha sido adecuadamente atravesada por los dilemas de la integración y de la diferencia. Estos dilemas estructuran dos núcleos problemáticos centrales: por un lado, el trabajo de las disciplinas y la dificultad para articular saberes ante realidades complejas; por otro lado, la garantía de la igualdad de derechos sin que ello implique la anulación de la diversidad humana. Ambos aspectos se encuentran intrínsecamente vinculados y requieren ser deconstruidos para evitar la perpetuación de un modelo asistencial segregatorio y excluyente.

En relación con el primer núcleo problemático, el trabajo de las disciplinas, se observa la persistencia de una Matriz Formativa Tradicional en la enseñanza universitario-profesional de las ciencias de la salud. Esta matriz, forjada en el contexto de la modernidad occidental, eurocéntrica, capitalista, patriarcal y científicamente positivista, opera como un obstáculo ontológico, epistemológico y praxiológico. Su enfoque fragmentario dio origen al denominado modelo psi hegemónico, cuyo exponente histórico ha sido el manicomio, un dispositivo basado en el encierro, el aislamiento relacional y la supresión de síntomas. Este modelo ejerce el normalismo, entendido como una operación que delimita simultáneamente la noción de lo normal y la imposición de la norma, regulando las subjetividades para adaptarlas a un orden social determinado. Frente a esta lógica unidisciplinaria, las epistemologías integrativas —derivadas del constructivismo de Jean Piaget y Rolando García, y del pensamiento complejo de Edgar Morin y la Salud Colectiva latinoamericana— proponen abordar la realidad a través de un tránsito dialéctico entre tres momentos operacionales: el momento *intra* (donde se construye la identidad y especificidad del objeto de cada disciplina), el momento *inter* (donde objetos disciplinarios diferenciados establecen relaciones de reciprocidad) y el momento *trans* (donde se elaboran operaciones de conjunto para intervenir sobre problemas de alta complejidad). El dilema de la integración plantea que estos momentos no corresponden a un orden jerárquico ni lineal, sino a una necesidad procesual e impostergable para superar la mercantilización y fragmentación de los servicios.

El segundo núcleo problemático atañe a la igualdad de derechos y se halla directamente articulado con el anterior, ya que la Matriz Formativa Tradicional carece del enfoque de derechos como eje estructurador de sus currículos. Debido a esto, las exigencias normativas de respeto a los derechos humanos ingresan a los servicios asistenciales como meros deberes tecno-burocráticos y no como una convicción ética u horizonte de sentido. Asimismo, la propia doctrina internacional de los derechos humanos requiere ser problematizada, dado que porta una matriz colonial y eurocéntrica que a menudo invisibiliza las divergencias culturales, de género y de capacidades. Para revertir esta limitación, resulta indispensable avanzar hacia una perspectiva decolonial, pluriversal y transmoderna de los derechos humanos, capaz de sostener el dilema de la diferencia acuñado por autoras feministas como Joan Scott y Marta Lamas. Este dilema establece que tanto enfatizar las diferencias como ignorarlas puede incrementar las desigualdades, por lo que el desafío ético consiste en no confundir igualdad con similitud: garantizar el derecho a un trato igualitario a personas diversas implica otorgarles el mismo estatus jurídico y asistencial sin exigirles que se despojen de sus singularidades ni tornarlas idénticas a un patrón hegemónico.

En la práctica asistencial concreta, la salud mental suele ejecutar operaciones de desmantelamiento del dilema de la diferencia al homogeneizar a los usuarios mediante binarismos que terminan reforzando estigmas y desviaciones. Una de las herramientas principales de este desmantelamiento es el uso performativo de la rotulación diagnóstica que, en el marco de una creciente sobremedicalización, busca similitudes donde prevalecen las particularidades de la vida cotidiana. Esta lógica homogeneizadora impacta severamente en dimensiones trazadoras como el género y la cultura. En el campo del género, la organización hospitalaria y las tecnologías de atención persisten en una lógica binaria (femenino-masculino) basada únicamente en la división sexual biológica, incapaz de alojar las variadas combinaciones entre la sexuación, las identidades de género y las dimensiones psíquicas individuales, derivando habitualmente en respuestas punitivas como la sobremedicación, el aislamiento o la prolongación injustificada de internaciones. En cuanto a la dimensión cultural, los encuadres profesionales imponen pautas occidentales sobre el manejo del tiempo, el idioma, el sufrimiento y los cuidados, igualando la atención a costa de disciplinar e imponer una heteronormatividad de matriz blanca e ilustrada. Superar la encrucijada actual exige desandar estas operaciones normalizadoras mediante una matriz formativa alternativa y contrahegemónica que asuma la integración disciplinaria y responda a las necesidades de la población desde la equidad, garantizando la accesibilidad y la calidad del servicio en pleno respeto por la diversidad humana.

U1.02. Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

02. **Stolkiner, A.** "Derechos Humanos y Salud desde el Pensamiento Médico Social / Salud Colectiva Latinoamericano".

RESUMEN DETALLADO.

El constructo moderno de los derechos humanos emerge como un producto paradójico de la modernidad capitalista. Originado en el seno del pensamiento liberal e ilustrado, se cimentó sobre una concepción esencialista e individualista del ser humano que, en su propio proceso de formulación, produjo sus propias «excepciones»: aquellas poblaciones consideradas incapaces de ejercerlos o excluidas del modelo de sujeto hegemónico, tales como los pobres, los pueblos colonizados, las mujeres, las infancias y las personas al margen de la norma productiva. Sin embargo, el devenir histórico convirtió a los enunciados de derechos en una «promesa incumplida de la modernidad», abriendo la posibilidad de que los propios sectores excluidos se organizaran para exigir su ampliación progresiva. En América Latina, las luchas de los movimientos sociales frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado —entendido como la suspensión arbitraria de la ley por parte del propio Estado para amedrentar a la sociedad e imponer modelos de concentración económica— resignificaron los derechos humanos. De este modo, el discurso de los derechos se transformó en una potente «idea fuerza», una herramienta simbólica y política capaz de estructurar movimientos emancipatorios regionales y aportar a la construcción de una cultura jurídica cosmopolita.

Este proceso cobra relevancia crítica en el siglo XXI frente al antagonismo estructural de la época: la tensión entre una tendencia global que subordina el valor de la vida a la acumulación de riqueza y las fuerzas sociales que pugnan por situar la defensa de la vida y la naturaleza en el centro de la acción colectiva. La comprensión emancipatoria de los derechos humanos requiere discutir la noción liberal de libertad, definida tradicionalmente por el pensamiento burgués como la autonomía del individuo respecto al Estado y la garantía de la libertad de mercado y propiedad privada. Bajo esa mirada consensual, formulada en la premisa de que los derechos propios terminan donde comienzan los del otro, el semejante es percibido como un límite o un obstáculo externo. En contraposición, una concepción no liberal y colectiva concibe la libertad a partir de la intersubjetividad, donde los derechos son fundamentalmente «los derechos del otro» y la falta de garantía para los demás degrada los derechos propios a meros privilegios sustentados en la violencia. Asimismo, este enfoque requiere superar tanto el universalismo eurocéntrico como el relativismo cultural mediante un diálogo transcultural, incorporando paradigmas originarios como el *Buen Vivir* o *Sumak*

Kawsay, el cual antepone la armonía comunitaria y el respeto a la naturaleza por sobre la competencia y la ganancia.

La dimensión filosófica de este antagonismo se explica mediante la tensión entre los procesos de objetivación y subjetivación. La objetivación remite al fenómeno de fetichización descrito por Karl Marx, mediante el cual las relaciones entre personas adquieren la apariencia de relaciones entre cosas, otorgando a la vida humana o a sus componentes una «situación mercantil» que los transforma en insumos intercambiables con un precio asignado. La manifestación extrema y metafórica de la objetivación radica en los dispositivos del terror estatal y el campo de concentración, estableciendo una continuidad entre la mercantilización y la anulación lisa y llana del sujeto. Por el contrario, la subjetivación constituye la praxis antagónica orientada a garantizar la dignidad humana, la cual se define éticamente por su no-intercambiabilidad mercantil: aquello que posee dignidad es un fin en sí mismo, insustituible y no reducible a la condición de instrumento o mercancía. Frente a corrientes bioéticas reduccionistas que intentan reemplazar la dignidad por una noción abstracta de "autonomía individual" que justifique, por ejemplo, la venta de órganos en contextos de pobreza, la perspectiva integral plantea que la dignidad es la condición indispensable para el ejercicio real de la libertad.

Al trasladar esta disputa al campo de las políticas públicas, el conflicto se cristaliza en la oposición entre considerar la salud como un derecho humano integral o como una mercancía transable en el mercado. Durante la hegemonía neoliberal del Consenso de Washington en la década de 1990, promovida por organismos financieros multilaterales, se procuró borrar la noción de derechos sociales. Se introdujeron herramientas técnico-estadísticas como los AVAD (Años de Vida Ajustados por Discapacidad) para medir la costo-efectividad de las intervenciones, llegando a equiparar técnicamente la vida con discapacidad a la muerte prematura para restringir el acceso estatal a tratamientos de alta complejidad a quienes no pudieran pagarlos. En las décadas posteriores, la deslegitimación del neoliberalismo radical dio paso a las propuestas de "segunda reforma del Estado" y a la noción de "cobertura universal de salud". Sin embargo, estos esquemas frecuentemente atenúan el discurso sin alterar la lógica de fondo, pues sustituyen el derecho universal por seguros de salud segmentados que ofrecen un "mínimo decente" o "derechos humanos de baja intensidad", manteniendo la fragmentación social y subordinando las prestaciones indispensables a la capacidad económica del asegurado. Asimismo, esta lógica fomenta la medicalización y la biomedicalización, procesos biopolíticos que transforman el malestar social o situaciones vitales en patologías farmacológicamente tratables, creando mercados cautivos a favor del complejo médico-industrial.

Frente a estas dinámicas, el pensamiento de la Medicina Social y la Salud Colectiva Latinoamericana reivindica una concepción compleja del proceso salud-enfermedad-cuidado que exige la garantía de la integralidad del derecho a la salud. Como lo establece la Observación General 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la salud no se limita a estar sano ni a la sola asistencia médica, sino que demanda acciones estatales positivas e indeclinables sobre los determinantes sociales —como el acceso al agua potable, la nutrición adecuada, la vivienda digna, ambientes laborales sanos y educación— e incluye explícitamente el derecho a la no-medicalización de la vida. Las experiencias regionales, como la creación del Sistema Único de Salud (SUS) en la Constitución brasileña de 1988 o la incorporación de los derechos de la naturaleza en las Cartas Magnas de Bolivia y Ecuador, demuestran la viabilidad de construir modelos alternativos. En conclusión, garantizar el derecho a la salud en América Latina plantea el reto de transformar las estructuras socioeconómicas y la organización de los servicios, asegurando que cada intervención en salud opere como una praxis emancipatoria de subjetivación que reconozca a las personas y comunidades como sujetos plenos de derecho.

Luciani Conde, L. (2021) “Por una matriz formativa alternativa en Salud Mental: Aportes de los estudios decoloniales al campo de la salud Mental Colectiva / Medicina Social Latinoamericana. Salud Mental y Comunidad”.

Teóricos y Prácticos. “Salud Pública y Mental” Cát.: TAJER.

Luciani Conde, L. (2021). Por una matriz formativa alternativa en Salud Mental: Aportes de los estudios decoloniales al campo de la Salud Mental Colectiva/Medicina Social Latinoamericana.

El artículo de Leandro Néstor Luciani Conde postula la necesidad impostergable de transformar la formación académica y las prácticas asistenciales en salud mental a partir de los aportes de los estudios decoloniales y el movimiento de la Salud Mental Colectiva y la Medicina Social Latinoamericana. El autor sostiene que las disciplinas contemporáneas de la salud continúan subordinadas a una «matriz formativa tradicional», entendida como una estructura curricular y conceptual heredada de la modernidad eurocéntrica, capitalista y patriarcal, que valida exclusivamente la racionalidad técnica, el positivismo empírico y la fragmentación del saber. Para desarticular esta hegemonía, el texto recupera la distinción fundamental entre «colonialismo» —el período histórico de dominación político-administrativa ejercido por las metrópolis europeas y formalmente concluido tras las independencias— y «colonialidad», noción acuñada por Aníbal Quijano para describir la continuidad estructural de los patrones de dominación, jerarquización social y explotación que persisten en la actualidad a través de la «colonialidad del poder» y la «colonialidad del saber». Esta dinámica tardomoderna impone la figura del varón blanco europeo como parámetro universal de humanidad y progreso, relegando a la subalternidad cualquier cosmovisión diferente.

Frente a esta matriz hegemónica, el autor propone asumir el «giro decolonial», concebido como un movimiento ético, político y epistémico que descentra a Europa como el único referente válido del conocimiento y promueve la «transmodernidad», concepto de Enrique Dussel que visibiliza la existencia y vitalidad de múltiples culturas silenciadas por la conquista. Dicha imposición histórica se consolidó mediante una severa «violencia epistémica» y un «racismo cognitivo», procesos mediante los cuales la ciencia moderna occidental suprimió, descalificó y exterminó los conocimientos de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos al catalogarlos como formas de barbarie o saberes precientíficos. En el ámbito de la salud, esta opresión operó de manera análoga: la ciencia positivista occidental impuso privilegios epistémicos sobre el discurso médico hegemónico, silenciando tanto los marcos explicativos ancestrales como la propia voz y vivencia de las personas con sufrimiento psíquico.

Luciani Conde enfatiza que la colonialidad y la institución manicomial han sido procesos coetáneos y co-constitutivos en la historia de nuestro continente, donde el modelo asilar custodial funcionó como un dispositivo disciplinario al servicio de la colonización y el control social. Este entramado instituyó un conjunto de

«binarismos y normalismos» —tales como razón/locura, mente/cuerpo, salud/enfermedad, normal/desviado o masculino/femenino— que reducen la complejidad del psiquismo y legitiman prácticas coercitivas. Por esta razón, el autor introduce el neologismo «descolomización», una categoría analítica y praxiológica que condensa la necesidad de fusionar de manera indisociable los procesos de *descolonización* de las relaciones de poder y saber con la *desmanicomialización* o clausura de las lógicas asilares, extendiendo la crítica hacia la subjetividad de los propios profesionales que reproducen estos mandatos en su práctica cotidiana.

Para materializar una matriz formativa alternativa, el texto argumenta que no basta con una inclusión cosmética o una sumatoria folclórica de contenidos bajo la etiqueta de la interculturalidad, sino que es imprescindible garantizar una auténtica justicia cognitiva mediante el diálogo con epistemologías emergentes no eurocéntricas. Entre ellas, destacan las «Epistemologías del Sur» formuladas por Boaventura de Sousa Santos —que conciben al Sur no como un punto cardinal, sino como una metáfora del sufrimiento provocado por el capitalismo y el colonialismo, demandando una ecología de saberes que recupere realidades suprimidas—; el «pensamiento fronterizo» de Walter Dignolo, que propone un diálogo intercultural desde la frontera de la subalternidad para superar la escisión cartesiana entre sujeto y objeto; y la «epistemología ch'ixi» de Silvia Rivera Cusicanqui, término aymara que describe la coexistencia simultánea y abigarrada de elementos opuestos y heterogéneos sin que uno anule o asimile destructivamente al otro.

Finalmente, el autor convoca a articular estos marcos con el rico legado de la Salud Mental Colectiva y la Medicina Social Latinoamericana, corrientes críticas que desde la década de 1970 han cuestionado el biologicismo y el positivismo mediante la teoría de la determinación social de la salud y la defensa de los derechos humanos. Si bien las reformas psiquiátricas y los enfoques comunitarios constituyeron avances esenciales en la democratización de la atención, Luciani Conde advierte que muchas de estas propuestas aún reproducen esquemas originados en los países centrales. En consecuencia, el horizonte de una salud mental colectiva decolonial reside en redefinir el bienestar como un proceso pluriversal y multidimensional de garantía de derechos que trascienda los límites clínicos individuales para enlazar la salud con el paradigma del «buen vivir», integrando de forma armónica los planos personal, familiar, comunitario y planetario en abierta ruptura con el modelo moderno, colonial, patriarcal y capitalista.

Teóricos y Prácticos. “Salud Pública y Mental” Cát.: TAJER.

Rep. Arg. (201) Ley 26.657, Ley Nacional de Salud Mental. Derecho a la Protección de la Salud Mental. Decreto Reglamentario 603/2013, Capítulos I – IV. Recuperado el 27 de octubre de 2015.

El Decreto Reglamentario 603/2013 reglamenta los primeros cuatro capítulos de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 de la República Argentina, consolidando un marco normativo e institucional que reemplaza el modelo tutelar e institucionalizante por un paradigma basado en los derechos humanos y la atención comunitaria. En sus considerandos y disposiciones generales, la norma fundamenta su intervención en los estándares de la Organización Mundial de la Salud, la Declaración de Caracas y los tratados internacionales de rango constitucional, estableciendo la responsabilidad indelegable del Estado y concibiendo la internación psiquiátrica únicamente como una medida restrictiva y último recurso terapéutico. Para garantizar la articulación de estas políticas, se crea la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con financiamiento específico por cartera y la obligación de convocar trimestralmente a un Consejo Consultivo honorario integrado por organizaciones de usuarios, familiares y trabajadores del sector.

En el marco del Capítulo I, el decreto define el término «padecimiento mental» como todo tipo de sufrimiento psíquico de las personas o grupos humanos, ya sea producto de crisis previsibles o imprevistas, o bien de situaciones prolongadas que incluyan trastornos y enfermedades. Esta definición abandona las perspectivas exclusivamente biologicistas y lo conceptualiza como un proceso complejo y determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Por su parte, el Capítulo II delimita el alcance de las políticas públicas y las adicciones desde una perspectiva de salud integral centrada en la singularidad del individuo. En concordancia, se introduce una definición no restrictiva de «servicios de salud», caracterizándolos como cualquier propuesta o alternativa de abordaje orientada a la promoción de la salud mental, prevención del sufrimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, inclusión social, reducción de daños evitables o apoyo y acompañamiento, tanto en efectores públicos como privados.

El Capítulo III aborda el ámbito de aplicación y establece la obligatoriedad universal de las disposiciones de la ley. La autoridad de aplicación, de manera conjunta con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe asegurar que todos los subsectores del sistema de salud adecuen su cobertura a las exigencias de la ley. Esta exigencia alcanza a las obras sociales nacionales y provinciales, al Instituto

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), a las entidades de medicina prepaga, a las obras sociales del Poder Judicial, del Congreso, de las universidades, de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, así como a cualquier agente prestador de salud, con independencia de su naturaleza jurídica.

El Capítulo IV detalla y operativiza los derechos y garantías de las personas usuarias de los servicios de salud mental, señalando que las prácticas terapéuticas permitidas deben contar con fundamentos científicos ajustados a principios éticos determinados por la autoridad de aplicación, quedando prohibidas aquellas que no cumplan dichos criterios. Asimismo, se promueve la inclusión y la lucha contra la estigmatización mediante la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). En el plano institucional, se impone a todos los establecimientos de salud la obligación de exhibir cartelera visible con dimensiones mínimas de 80 por 50 centímetros que informe sobre los derechos del usuario y los canales de denuncia, así como el deber de entregar una copia formal del artículo 7° de la ley a los pacientes y sus familias al momento del ingreso en una internación.

En cuanto a la autonomía de la voluntad, la reglamentación faculta a las personas —o a sus representantes legales— a formalizar «directivas anticipadas», entendidas como instrumentos vinculantes para consentir o rechazar tratamientos y decisiones sobre su salud mental, las cuales deben ser obligatoriamente acatadas por el equipo interdisciplinario y asentadas en la historia clínica, con la única excepción de que impliquen un riesgo cierto para sí o para terceros. De forma análoga, se resguarda la estricta confidencialidad de la información sanitaria, cuya divulgación a terceros o utilización en ámbitos académicos requiere el consentimiento expreso del paciente y la reserva de su identidad.

El texto define formalmente el «consentimiento fehaciente» como la manifestación libre y suficiente de la voluntad emitida por el paciente tras recibir información clara y detallada sobre su diagnóstico, los objetivos, riesgos, beneficios y efectos adversos de los procedimientos propuestos, así como las alternativas existentes y las consecuencias de su rechazo. Para evitar situaciones de coacción, se estipula que dicho consentimiento debe prestarse ante un organismo público fuera de contextos de internación involuntaria o restricción de la libertad, sometiendo cualquier investigación clínica o tratamiento experimental a la aprobación previa de la autoridad de aplicación en consulta con el Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos y el Órgano de Revisión. Finalmente, se consagra el derecho a una «justa compensación», entendida como la retribución económica correspondiente a la fuerza de trabajo del paciente cuando este participe en la

producción de bienes o servicios comercializables, garantizando la fiscalización estatal coordinada con el Ministerio de Trabajo para erradicar cualquier práctica de explotación laboral.

U1.03. Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

02. **Stolkiner, A.** "Medicalización de la vida".

RESUMEN DETALLADO.

El fenómeno actual de la medicalización de la vida constituye el analizador privilegiado de la articulación entre lo económico, lo institucional y la vida cotidiana, expresando en el campo sanitario el antagonismo central de la época: la tensión entre la **objetivación** y la **subjetivación**. La objetivación remite al proceso de fetichización analizado por Karl Marx, mediante el cual las relaciones humanas adquieren la apariencia de relaciones entre cosas, otorgando a la vida, al cuerpo y al malestar una "situación mercantil" que los reduce a objetos e insumos de producción y ganancia. En contraposición, la subjetivación —conceptualizada por autores como Giorgio Agamben y Antonio Negri— desontologiza la idea de un "individuo" sustancial o predeterminado para definir al sujeto como un devenir histórico, común y potente; un proceso continuo de invención cuya dignidad reside en su irreductibilidad a los dispositivos que intentan capturarlo. Históricamente, la medicalización operó como un dispositivo biopolítico de gubernamentalidad estatal enfocado en la normalización de las poblaciones. Sin embargo, en la fase contemporánea se despliega la **biomedicalización**, impulsada por la mercantilización de la salud a través de corporaciones farmacéuticas y aseguradoras. Este nuevo modelo promueve la internalización de una "moral del cuerpo" y una cultura de "malestar cero", donde los propios individuos ejercen una autovigilancia preventiva de riesgos potenciales, consumiendo fármacos para responder a exigencias del mercado sin necesidad de una prescripción médica directa.

Esta dinámica se consolida mediante la construcción de una **hegemonía discursiva**, definida por Marc Angenot como el conjunto de normas pragmáticas e imposiciones que establecen la jerarquía de las legitimidades, indicando qué temas son aceptables y otorgando a un "enunciador legítimo" la facultad de fiscalizar y nombrar a las alteridades subalternizadas. Un ejemplo claro de este mecanismo ocurre cuando vivencias cotidianas de dolor social —como el "quebranto" expresado por mujeres de sectores populares ante el desempleo o la pérdida familiar— son traducidas de inmediato por la mirada técnica como "depresión". De este modo, la experiencia subjetiva es expropiada y redefinida en términos de una categoría psicopatológica individual. Ligado a esta hegemonía discursiva se encuentra el fenómeno del **disease mongering** o creación de enfermedades, una estrategia corporativa derivada del desplazamiento del *ethos* académico tradicional hacia un *ethos* corporativo en la investigación científica. A través de alianzas entre industrias farmacéuticas, empresas de

marketing y grupos de investigación, se aíslan procesos vitales o riesgos estadísticos para nominarlos como "síndromes" o "enfermedades" (tales como el trastorno por déficit de atención, el síndrome de oposiciónismo desafiante en niños o el trastorno de hipersexualidad), ofreciendo como respuesta única el consumo de psicofármacos. Esta distorsión mercantil provoca que se inviertan enormes recursos en condiciones de alto mercado mientras las llamadas "enfermedades huérfanas" —graves pero de baja prevalencia— quedan desatendidas por no constituir un negocio rentable.

La expansión de este modelo encuentra un sustento crucial en la extensión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), cuya elaboración por una corporación psiquiátrica estadounidense se impone con pretensiones de universalidad, desplazando particularidades regionales como las contempladas en la Guía Latinoamericana de Diagnósticos Psiquiátricos. El DSM-5 amplía las fronteras de la patología mediante la patologización de procesos vitales —por ejemplo, al habilitar el diagnóstico de depresión clínica ante la persistencia de tristeza durante solo dos semanas posteriores a un duelo— y la utilización del "riesgo" como diagnóstico de intervención, como ocurre con la categoría de "síndrome de riesgo de psicosis" que legitima la medicación preventiva en adolescentes. Una muestra de la subordinación política del sentido a la nosografía es la difusión del "trastorno de estrés postraumático", una categoría que iguala el sufrimiento de un veterano de guerra, una víctima de violación o un sobreviviente de terrorismo de Estado, reduciendo el hecho traumático a una respuesta fisiológica individual. Al omitir las condiciones colectivas de producción del trauma, la nosografía invisibiliza la inexpresable angustia existencial y despolitiza el conflicto social, intentando solucionar mediante psicofármacos situaciones donde lo que ha sido lesionado es la trama de significación histórica y comunitaria del sujeto.

Frente a la hegemonía nosográfica, se vuelve indispensable introducir la categoría de **sufrimiento psíquico o subjetivo** —desarrollada en la epidemiología crítica por Cecilia Ausburger— para diferenciar el dolor vital de la patología mental. El sufrimiento subjetivo abarca las manifestaciones de dolor inherentes a las vicisitudes sociales, afectivas e históricas de la existencia, las cuales no conducen necesariamente a la enfermedad ni se agotan en ella. Reducir el sufrimiento a una categoría psicopatológica produce un segundo movimiento de desubjetivación, ya que ontologiza el malestar transformándolo en algo del orden del "ser" e impregnándolo de estigma social. Todas las prácticas en salud poseen un componente técnico-disciplinar potencialmente objetivante; por ello, campos como el psicoanálisis requieren de una permanente **vigilancia epistemológica** y reflexividad crítica sobre sus propios marcos conceptuales. El psicoanálisis puede deslizarse hacia la objetivación si ontologiza las estructuras clínicas

convirtiéndolas en dogmas abstractos, si confunde al sujeto del inconsciente con el "individuo" burgués (relegando la dimensión del cuerpo, la clase, el género y la cultura) o si concibe el consultorio privado como un espacio neutro ajeno a las leyes del mercado.

Para contrarrestar la objetivación medicalizante, el pensamiento en Salud Colectiva propone avanzar hacia una **clínica ampliada** y hacia prácticas centradas en el **cuidado**. La clínica ampliada desplaza el eje desde la "ontología de la enfermedad" hacia la persona singular en su contexto histórico, subordinando la intervención técnica disciplinar al reconocimiento del otro como un sujeto con capacidad de innovación y sujeto de derechos. Esta perspectiva exige una ética de la **hospitalidad**, un concepto desarrollado por Jacques Derrida que define la escucha clínica como un acto de acogida incondicional hacia la alteridad del paciente, donde el profesional acepta dejarse interrogar en sus certezas y saberes teóricos por la pregunta del sufriente. Asimismo, el acto analítico y la escucha clínica requieren de condiciones objetivas de dignidad para ser posibles, resultando incompatibles con dispositivos asilares o prácticas manicomiales que privan al sujeto de su palabra y lo colocan en un estado de hiposuficiencia jurídica. En última instancia, la deconstrucción de la medicalización no busca el rechazo de los saberes médicos o farmacológicos, sino su rectificación crítica para que la dimensión subjetiva sea reintegrada en la totalidad de las prácticas en salud, garantizando que la tecnología y el conocimiento científico permanezcan subordinados a la emancipación y al cuidado de la vida.

U1.03. Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

01. **Stolkiner, A.** "Las formas de transitar la adolescencia hoy y la salud. Salud mental: actores y escenarios"

RESUMEN DETALLADO.

La comprensión de las problemáticas de salud en la juventud requiere revisar críticamente la noción fragmentada de «salud mental», un constructo cartesiano que históricamente separó la mente, el cuerpo y la sociedad para dar respuesta institucional a la locura mediante modelos asilares. Desde la perspectiva de la Salud Colectiva, la salud mental no constituye un tipo particular de salud fragmentada, sino un subcampo de prácticas sociales configurado por instituciones, actores y producciones de sentido específicas. Por ello, resulta preferible utilizar la categoría **proceso de salud-enfermedad-cuidado** en sustitución de la tradicional noción de "atención". La inclusión del concepto de *cuidado* —enriquecido por los aportes de las teorías feministas y la ética del cuidado— permite visibilizar la red de prácticas comunitarias, familiares y colectivas que suceden fuera de los establecimientos sanitarios, superando la falsa antinomia entre el beneficio individual y la ayuda mutua. En este proceso continuo, la salud no se define como un estado fijo, sino como una trama social donde interactúan corporeidades y **subjetividades**. Siguiendo la definición de Giorgio Agamben, la subjetividad no es una esencia sustancial, sino el resultado del encuentro «cuerpo a cuerpo» con los *dispositivos* sociales (el lenguaje, las leyes, las instituciones), los cuales gestionan la vida e inscriben directamente sobre los cuerpos las transformaciones biológicas, laborales y culturales de la época.

Para abordar la complejidad de este proceso sin caer en reduccionismos, la investigación interdisciplinaria requiere articular metódicamente tres dimensiones y tres niveles de análisis. Respecto a las dimensiones, la dimensión *económica* refiere a los modos de producción, acumulación y mercantilización de los lazos sociales; la dimensión *institucional* abarca las formas históricas específicas que adoptan las relaciones humanas (como la familia, la escuela o los modos de contratación laboral); y la dimensión de la *vida cotidiana* —siguiendo a Ágnes Heller— constituye el espacio donde se particulariza lo genérico social mediante la organización del tiempo, el espacio y la reproducción de la existencia singular. Por su parte, la articulación por niveles (macro, meso y micro), tomada de la teoría de los sistemas complejos de Rolando García, permite comprender micro-episodios sociales a la luz de las condiciones generales. Un ejemplo claro de esta interacción ocurrió durante las reformas del sector salud en la década de 1990, cuando las políticas de corte neoclásico (nivel macro) impusieron criterios de productividad mercantil a la gestión hospitalaria (nivel

meso), forzando una aceleración casi fordista del tiempo de atención médica que redujo la consulta (nivel micro) a un acto puramente prescriptivo, erosionando la práctica clínica y potenciando el consumo de medicamentos y tecnologías diagnósticas.

En este marco metodológico, la adolescencia hoy no puede ser analizada como una categoría homogénea, sino como un constructo social y cultural atravesado por profundas desigualdades de clase en el acceso a recursos materiales y simbólicos. En el plano jurídico, la derogación de la histórica *Ley de Patronato* y la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño con Rango Constitucional generaron la paradoja de un Estado que avanzó en la proclamación formal de derechos en un contexto de vulneración social generalizada. Simultáneamente, la penetración de la lógica de mercado instaló en la subjetividad juvenil las categorías de "ganadores" (*winners*) y "perdedores" (*losers*), las cuales no evalúan la genealogía ni la condición del sujeto, sino únicamente su posición en una sociedad concebida como espacio de competencia mercantil. Esta dinámica impacta de manera diferenciada según el sector social: mientras en las clases medias genera el terror al error o al fracaso, paralizando el deseo y la potencia de proyección futura ante el pánico de caer a un precipicio social, en los sectores populares impone una extrema fragilidad existencial, la asunción temprana de roles adultos de subsistencia y una marcada exposición a la violencia.

Frente a estas vicisitudes, el discurso técnico, disciplinar y mediático hegemónico tiende a reproducir una mirada reduccionista que define a la juventud bajo el supuesto permanente de "peligro o estar en peligro", asociándola unilateralmente al fracaso, las adicciones o la violencia. Esto deriva en un acelerado proceso de psicopatologización y medicalización de la vida cotidiana, donde los conflictos sociales e históricos son traducidos a clasificaciones mórbidas y abordados mediante fármacos o terapias estandarizadas. Frente a ello, es indispensable distinguir la patología mental del **sufrimiento psíquico o subjetivo**, entendiéndolo como aquel padecimiento procesual derivado de las condiciones concretas de existencia que no desemboca necesariamente en una enfermedad. Ante el desamparo institucional y la caída de las formas autoritarias de ejercicio del poder, los jóvenes reaccionan frecuentemente funcionando como **analizadores**: sujetos, actos o acontecimientos sintomáticos (como el autolesionismo o la violencia escolar) que, aun sin una intencionalidad consciente de cambio, irrumpen con el cuerpo desnudando y colocando en el discurso público las contradicciones, vacíos y violencias institucionales que la sociedad mantenía naturalizadas o invisibilizadas. El desafío ético y político de las prácticas en salud mental consiste en evitar la clausura diagnóstica y facilitar el pasaje de los adolescentes de *analizadores* a **actores**. Convertirse en actor implica construir espacios de intencionalidad, asociatividad y agencia social, donde los jóvenes no sean meros

destinatarios pasivos de programas de adaptación, sino co-constructores de sus propios proyectos de vida. Para ello, los adultos, educadores y profesionales de la salud deben reconstruir su autoridad no desde la imposición jerárquica vertical, sino legitimándola a través del cuidado, la escucha activa y la generación de espacios de intersubjetividad regulados por la ley y la palabra. En una época caracterizada por la prolongación potencial de la vida, la adolescencia debe ser reivindicada y garantizada como un derecho humano fundamental; es decir, como un período socio-histórico indispensable de exploración, ensayo, aprendizaje por error y proyección deseante que la sociedad en su conjunto debe proteger.

U1.03. Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

03. **Stolkiner, A.** "Subjetividades de época y prácticas de Salud Mental".

RESUMEN DETALLADO.

Las narraciones que emergen en la práctica clínica cotidiana —tales como la vivencia del delito callejero, la angustia docente ante el conflicto laboral o la desorientación adolescente— no constituyen meros padecimientos individuales o psicológicos, sino que expresan un claro **registro de época** que evidencia el impacto de las transformaciones sociales en la salud mental. Para abordar esta complejidad sin caer en dualismos cartesianos que dividan lo psíquico de lo social, la investigación interdisciplinaria propone articular metódicamente tres dimensiones interconectadas: la dimensión *económica* (centrada en los modos de producción y la hegemonía del mercado financiero), la dimensión *institucional* (que analiza las mutaciones en la familia, el trabajo y las políticas estatales) y la dimensión de la *vida cotidiana* (definida por Ágnes Heller como el espacio donde se particulariza singularmente la reproducción de la existencia social). Este enfoque evita las determinaciones lineales y asume una perspectiva procesual para comprender de qué modo las crisis estructurales redefinen las condiciones de producción de la subjetividad y del padecimiento humano.

La transformación macroeconómica iniciada a finales del siglo XX y profundizada durante la década de 1990 en la Argentina marcó el pasaje histórico de una **sociedad de integración** a una **sociedad de exclusión**. En el "viejo país" de la integración, el trabajo estable funcionaba como el gran organizador de la cotidianidad, inscribiendo a los sujetos en redes formales de seguridad (Estado, sindicatos, comunidad) y sosteniendo una temporalidad orientada por la representación del progreso social y la movilidad intergeneracional. En la "nueva sociedad" de la exclusión, la flexibilización laboral, la desocupación masiva y la concentración de la riqueza destruyeron la previsibilidad del futuro, fragmentando las identidades y generalizando la incertidumbre. En este nuevo escenario, el fantasma de "quedar afuera" atraviesa a todos los estratos sociales, transformando la exclusión en un espejo atemorizante que altera la construcción de los vínculos y la percepción del propio estatus social.

En todas las formas institucionales de este escenario contemporáneo se despliega el antagonismo central entre la **objetivación** y la **subjetivación**. La tendencia a la objetivación deriva de la lógica mercantil que reduce las relaciones humanas a intercambios entre equivalentes, produciendo la figura del "individuo posmoderno": una subjetividad desprovista de memoria e identidad sustancial, motivada únicamente por un impulso infinito al consumo y la apropiación, para quien los semejantes son percibidos como amenazas u obstáculos externos. En el

polo opuesto, la tendencia a la subjetivación se fundamenta en la exigencia de ciudadanía y la efectivización de los derechos humanos como horizonte para un nuevo contrato social. Bajo este polo, el **sujeto** es conceptualizado —siguiendo la reformulación spinoziana de Antonio Negri— como un proceso histórico común y potente: "común" porque se compone de las necesidades compartidas de producción de la vida, y "potente" porque posee la capacidad de romper las determinaciones biológicas o mecánicas para crear innovación, producir excedente de vida y ejecutar la reapropiación comunitaria de la existencia.

Frente al ambiente traumático crónico generado por la pérdida de amparo estatal y la fragilización de las redes sociales, los sujetos despliegan diversas respuestas subjetivas para procesar el desamparo estructural (*hilflosigkeit*). Por un lado, se observan respuestas reactivas y violentas que invierten destructivamente la posición de víctima y victimario, o dinámicas de renuncia donde las personas deniegan activamente el deseo de bienes inaccesibles para aliviar el sufrimiento de la privación. Esta renuncia se evidencia también cuando usuarios vulnerables, imposibilitados de pagar aranceles o medicamentos, abandonan los tratamientos médicos confiando su salud a la fe religiosa y aceptando resignadamente la muerte. Por otro lado, emergen potentes formas de resistencia afirmativa: la capacidad de preservar la felicidad en el lazo afectivo familiar y comunitario a pesar de la carencia material, la búsqueda de raíces identitarias alternativas (como las identidades precolombinas frente al fracaso de la narrativa moderna de progreso) y la consolidación de nuevas redes solidarias organizadas desde la periferia social para hacer oír su palabra.

Este escenario impone una profunda **reflexividad** por parte de los trabajadores de la salud mental sobre sus propias prácticas y sobre las condiciones de precarización laboral en las que se desempeñan dentro de un sistema sanitario mercantilizado. Resulta imposible operar en la línea de la subjetivación de los usuarios si no se revisan y transforman las condiciones de objetivación que recaen sobre los propios profesionales, superando debates dogmáticos o ahistóricos que conciben la gratuidad hospitalaria como beneficencia y no como el ejercicio de un derecho republicano. Es en el primer nivel de atención —denominado por los trabajadores como "la trinchera"— donde se gestan las respuestas más innovadoras frente a la crisis. En contextos traumáticos, la elaboración del padecimiento subjetivo no se logra mediante la introspección aislada ni la aplicación de nosografías biológicas rígidas, sino mediante un abordaje interdisciplinario e intersectorial que restituya el lazo social. La salud mental debe desplegar dispositivos que faciliten el diálogo, la construcción de estrategias colectivas y la producción de discursos alternativos, garantizando que el sujeto sea reconocido en su potencia creativa y en su plena dimensión de ciudadanía.

U1.03. Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

04. **Stolkiner, A.** "Tiempos Posmodernos: Procesos de Ajuste y Salud Mental".

RESUMEN DETALLADO.

Así como la cinematografía de Charles Chaplin en *Tiempos Modernos* sintetizó la consolidación del fordismo y la gran crisis del capitalismo autoregulado de la década de 1930, la crisis estructural de la década de 1970 inauguró una nueva fase histórica signada por la mundialización financiera, la desestatización y la flexibilización laboral. En América Latina, la aplicación del modelo neoliberal difiere sustancialmente de la observada en los países centrales, pues mientras en estos últimos los procesos de marginación afectaron inicialmente a minorías, en la periferia el empobrecimiento abarcó a la mayoría de la población y el recorte del gasto público se orientó prioritariamente al pago de la deuda externa. Asimismo, la implantación de las políticas de ajuste en el subcontinente no ocurrió mediante consensos democráticos primarios, sino a través del Terror de Estado aplicado por dictaduras militares y del "terror económico" desatado por procesos hiperinflacionarios. Este trasfondo de coerción e inestabilidad configuró un trauma social duradero que sobrevivió a la restauración democrática formal, invisibilizándose en forma de apatía pasiva y condicionando profundamente las representaciones sociales, los funcionamientos institucionales y las formas de subjetivación.

Para comprender la producción de subjetividad y de padecimiento sin incurrir en reduccionismos economicistas, resulta indispensable utilizar la delimitación metodológica que articula lo económico, las formas institucionales y la vida cotidiana. Lo económico no opera como un factor externo que simplemente "influye" en las personas, sino que se entreteje en el texto mismo de la subjetividad al determinar las representaciones del tiempo, del trabajo y del valor. En episodios de crisis e hiperinflación, el dinero se devela crudamente en su función de equivalente general y significante de las relaciones humanas, desarticulando la continuidad temporal y la previsibilidad del futuro. A su vez, las formas institucionales —mecanismos de producción y reproducción social como el trabajo, la familia, la comunidad y el sistema de salud— sufren procesos de implosión y fragmentación donde los antiguos esquemas se rigidizan en rituales vacíos de sentido. Es en la vida cotidiana donde estas mutaciones macroeconómicas e institucionales se concretan singularmente, modelando los ritmos de trabajo, de descanso y las formas de enfermar o cuidar el cuerpo.

En este contexto de reestructuración social, la hegemonía mercantil promueve un modelo ideológico denominado **neo-individualismo**. A diferencia del clásico individuo burgués de la competencia capitalista naciente, capaz de posponer

satisfacciones inmediatas en función de una narrativa de progreso futuro y ascenso social, el neo-individualismo constituye un hedonismo de serie. Este modelo propone un consumidor estandarizado, centrado en placeres inmediatos y pautados por los medios de comunicación, cuya subjetividad se repliega sobre sí misma mediante la adquisición de objetos personales que sustituyen el encuentro con el semejante. La contracara de este individualismo masificado es el surgimiento de un perfil epidemiológico específico de padecimientos de época. Por un lado, la inestabilidad laboral y el temor al despido generan una alta prevalencia de trastornos psicosomáticos en los trabajadores integrados, derivados de la autoexigencia, la represión del conflicto y la sobrecarga productiva. Por otro lado, en la población desocupada, la pérdida de la identidad social y el derrumbe del proyecto existencial derivan en el incremento de cuadros psiquiátricos francos, depresiones severas y adicciones. Paralelamente, la crisis de la estructura familiar se manifiesta en el crecimiento del matrifocalismo —donde las mujeres asumen como cabeza y único sostén económico del hogar debido al desempleo masculino— y en la masividad de los "niños en situación de calle", quienes organizan redes atípicas de supervivencia infantil ante el repliegue de la protección adulta e institucional. La reestructuración neoliberal opera también una transformación sobre las instituciones de salud mental a través de una **falsa desmanicomialización**. Desde los centros de poder financiero se despliega una crítica al hospital psiquiátrico tradicional basada prioritariamente en su alto costo fiscal y su baja eficiencia operativa, proponiendo la reducción de camas y la externación de pacientes. Sin embargo, este cuestionamiento no responde a una política humanitaria de desarticulación de los supuestos de segregación, ya que los pacientes son devueltos a familias y comunidades precarizadas sin la creación de recursos económicos, terapéuticos y comunitarios sustitutivos. Al cesar el amparo estatal, el dispositivo manicomial de la exclusión y el abandono se independiza del edificio asilar y se traslada al conjunto de la trama urbana. En esta nueva topografía social, la sociedad misma funciona como una institución total: las poblaciones marginadas son confinadas al desamparo en asentamientos informales que operan como los "manicomios a cielo abierto" de la época, mientras los sectores integrados se abroquelan en barrios privados y espacios vigilados, delegando la contención de la fragmentación social a la represión policial o a la autodefensa. Frente a esta deriva segregatoria, la construcción de **propuestas contrahegemónicas** en salud mental debe asentarse sobre el eje ético-político innegociable de la defensa del derecho a la salud y del salario social, transformando la institución pública para democratizarla y romper sus barreras de accesibilidad. Una alternativa auténtica exige superar el modelo tecnocrático mediante la horizontalización de los servicios y la integración de las prácticas de salud mental dentro de la atención sanitaria general, reconociendo a los usuarios y trabajadores como actores protagonistas. Asimismo, debe evitarse la trampa del

asistencialismo neoliberal, el cual apela a discursos participativos con el único fin de recortar la financiación estatal y delegar el trabajo de cuidado no remunerado sobre las comunidades empobrecidas y las mujeres. La verdadera transformación se fundamenta en la **solidaridad**, entendida no como beneficencia —acto asimétrico donde quien cree tener da al que carece—, sino como el reconocimiento mutuo de la falta entre pares iguales que se articulan para la acción colectiva. En última instancia, la práctica en salud mental constituye un trabajo de producción de significaciones y generación de espacios imaginantes que resistan la estandarización subjetiva, restituyendo las redes sociales y devolviendo al sujeto su capacidad de proyectar el futuro.

U1.04. Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

01. **Elichiry, N.** "La importancia de la articulación interdisciplinaria para el desarrollo de metodologías transdisciplinarias".

RESUMEN DETALLADO.

En la educación universitaria y en el ámbito institucional de América Latina predomina una formación de matriz tradicional y positivista que fragmenta el conocimiento en compartimentos estancos. Este modelo disciplinario promueve una excesiva especialización que aísla el saber del contexto sociohistórico, favorece el dogmatismo mediante la creación de "escuelas" o modas intelectuales desconectadas de la realidad e incurre en una sistemática desarticulación entre la teoría —dictada en las aulas al inicio de las carreras— y la práctica, postergada al tramo final del trayecto formativo. El resultado de este enfoque es la constitución de "islas académicas" eruditas pero incapaces de responder a las demandas sociales y de generar conocimiento transformador. En este horizonte, es común confundir la interdisciplina con las prácticas de **multidisciplinariedad**, las cuales se caracterizan por una simple yuxtaposición o acumulación de áreas especializadas donde cada disciplina actúa aisladamente dentro de sus límites preconcebidos, sin que existan intercambios, modificaciones ni transformaciones en las estructuras de los saberes involucrados.

Frente al reduccionismo atomista, la aproximación hacia la **interdisciplinariedad** surge no desde la especulación teórica ni desde la demarcación rígida de las fronteras de cada materia, sino desde la emergencia de demandas sociales y "situaciones-problema" cada vez más complejas. La propuesta central exige partir de los problemas reales y no de las disciplinas dadas, asumiendo que los fenómenos no reconocen límites disciplinarios fijos. Este enfoque se sustenta en la epistemología constructivista desarrollada por Jean Piaget y en las reflexiones de Ilya Prigogine sobre la complejidad de la ciencia, comprendiendo la realidad como una totalidad estructurada y a la vez estructurante, donde coexisten la unidad y la diversidad. La interdisciplina constituye una interacción dinámica donde la reciprocidad produce un enriquecimiento mutuo y la transformación de las áreas intervinientes a través de la articulación convergente de sus instrumentos, códigos lingüísticos, técnicas y métodos.

Para que la articulación interdisciplinaria sea efectiva y no derive en una mera proclamación discursiva, es un prerequisite indispensable que los profesionales posean una sólida **especificidad e identidad disciplinaria**. Solo se puede establecer un diálogo interdisciplinario desde el dominio experto de la propia especialidad; de manera análoga a una orquesta musical, la integración armónica

de la obra exige que cada integrante sea previamente un ejecutante virtuoso de su instrumento específico (violín, oboe o piano). Manteniendo esa individualidad nítida, la interdisciplina exige el cumplimiento orgánico de seis condiciones complementarias: el trabajo en equipo basado en actitudes cooperativas; la intencionalidad o búsqueda deliberada del encuentro; la flexibilidad metodológica desprovista de dogmatismos; la cooperación recurrente que garantice la continuidad del grupo; la reciprocidad en los intercambios; y la integración sistémica, nivel donde cada disciplina desempeña su función de manera individual pero no independiente.

La culminación de esta articulación sistémica conduce hacia la **transdisciplinariedad**, concebida en términos de Piaget y Rolando García como una aproximación metodológica superior que sitúa las conexiones científicas dentro de un sistema total sin fronteras estables entre disciplinas, guiado por un marco conceptual común. Fundada en la teoría de los sistemas complejos y el estructuralismo constructivista, la transdisciplina concibe los fenómenos como conjuntos funcionalmente organizados donde priman los procesos dinámicos de regulación y la explicación histórica de las transformaciones. Este horizonte integrador permite esquivar tanto el riesgo de la especialización absoluta y el aislamiento, como el peligro de la generalización excesiva y la falta de rigor. En última instancia, avanzar hacia metodologías transdisciplinarias exige abandonar los dogmas de "saberes absolutos" para abrazar una actitud crítica de verificación recíproca, discusión abierta y trabajo colaborativo, haciendo converger la pluralidad de las ciencias en la resolución efectiva de las problemáticas complejas que plantea la realidad.

U1.04. Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

02. **García, R.** "Dialéctica de la integración en la investigación interdisciplinaria".

RESUMEN DETALLADO.

La investigación interdisciplinaria de sistemas complejos constituye un objeto de estudio unificado e indisoluble, donde el centro de la indagación se desplaza desde el debate abstracto sobre cómo reunir disciplinas hacia el modo en que se aborda la realidad. Es indispensable diferenciar un sistema complicado de un **sistema complejo**. Un sistema es complicado cuando cuenta con múltiples elementos entrelazados cuya estructura permite desarmarlos y analizarlos por separado, como ocurre en las artes mecánicas o en los oficios de la construcción. En cambio, un sistema complejo está definido por componentes heterogéneos que pertenecen naturalmente al dominio de diversas disciplinas, pero cuyas interacciones son de tal magnitud que ninguno de sus elementos puede ser definido de manera independiente fuera del contexto y de la trama de relaciones en la que se halla inmerso. Las propiedades fundamentales de un sistema complejo son de carácter emergente y estructural, lo que significa que el funcionamiento de la totalidad no equivale a la suma de las propiedades de sus partes. Esta condición se ilustra mediante la vulnerabilidad física de un objeto: la posibilidad de que una botella tambalee y se derrame ante una mínima perturbación no es una propiedad intrínseca de la botella, de la mesa o del suelo por separado, sino una propiedad emergente del conjunto de relaciones geométricas y de fuerza de gravedad que constituyen la estructura del sistema.

Dentro de todo sistema complejo es necesario distinguir la *estructura* (el conjunto de relaciones internas entre sus componentes), la *función* (el rol específico de cada subsistema) y el *funcionamiento* (la dinámica global del conjunto). Puesto que sistemas con estructuras materiales o socioeconómicas disímiles pueden exhibir funcionamientos análogos —del mismo modo que órganos biológicos con estructuras completamente distintas cumplen idénticas funciones respiratorias—, el eje de la investigación interdisciplinaria no debe situarse en la mera descripción de los componentes aislados, sino en la explicación de la estructura y de los *mecanismos de acción* que desencadenan las situaciones de deterioro social, ambiental o sanitario. Las investigaciones sobre los desastres climáticos en la región africana del Sahel demostraron que la mortandad masiva producida por las sequías del siglo XX no obedeció a una mayor severidad del fenómeno físico atmosférico, sino al incremento drástico de la vulnerabilidad social e institucional. La imposición de fronteras políticas coloniales que impidieron el desplazamiento ancestral de las poblaciones nómadas, junto con la reorientación del comercio

hacia la exportación de monocultivos, alteró la estructura del sistema, transformando una variación climática habitual en una catástrofe humanitaria.

En el plano epistemológico, el abordaje de sistemas complejos exige rechazar las premisas del empirismo ingenuo que suponen la existencia de "datos puros" o neutros en la realidad. Todo dato o variable observable constituye ya una abstracción e interpretación previa, cargada de marcos teóricos e implícitos ideológicos relativos a la concepción del mundo, de la sociedad y de la economía. Por esta razón, un equipo interdisciplinario no puede constituirse simplemente reuniendo especialistas de diversas materias alrededor de una mesa a debatir sus posibles aportes, ya que la ausencia de supuestos compartidos produce dispersión e incompreensión. Para que el equipo funcione, se requiere un consenso ideológico y epistemológico inicial respecto a la naturaleza del problema y a las preguntas fundamentales que se intentan responder. Los sistemas no están dados de forma transparente en la realidad, sino que son modelos conceptuales construidos y reconstruidos progresivamente por los investigadores a lo largo del proceso de indagación.

La metodología para construir dicho modelo sistémico opera mediante la **dialéctica de la integración**, un proceso fundamentado en la psicogénesis piagetiana desarrollada en la obra sobre la equilibración de los sistemas cognoscitivos. El trabajo de investigación no parte de la integración inmediata de las disciplinas, sino de la definición compartida de una problemática inicial. A partir de esa totalidad compleja pero difusa, el proceso procede mediante fases sucesivas de *diferenciación*, donde los especialistas estudian en profundidad aspectos particulares desprendidos del conjunto, para luego retornar a momentos de *integración*, en los cuales los hallazgos disciplinares reestructuran y enriquecen el modelo del sistema total. Esta oscilación recurrente entre diferenciaciones e integraciones rompe la lógica de la acumulación lineal y permite ajustar los marcos conceptuales a la dinámica de los hechos.

Finalmente, la evolución de los sistemas complejos se explica a través de las teorías de los sistemas abiertos e inestables desarrolladas por Ilya Prigogine, en confluencia con la epistemología genética de Jean Piaget. Los sistemas abiertos — físicos, biológicos o sociales— no evolucionan de manera lineal ni continua, sino mediante procesos de autoorganización y saltos cualitativos. Cuando las perturbaciones internas o externas superan determinados umbrales de equilibrio, el sistema atraviesa una fase de transición o caos determinado que culmina en una reorganización estructural en un nuevo nivel de estabilidad. Esta comprensión científica sustenta la prioridad absoluta del **diagnóstico sistémico** por sobre las urgencias de la acción tecnocrática. Cualquier intervención o formulación de políticas alternativas en el campo social o sanitario resultará ineficaz si no se

sustentan en un diagnóstico previo de los mecanismos de deterioro que afectan al sistema, desmontando los mitos de la economía de mercado y aportando al desarrollo de una conciencia pública crítica fundamentada en el conocimiento científico.

U1.04. Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

03. **Stolkner, A.** "De interdisciplinas e indisciplinas".

RESUMEN DETALLADO.

La emergencia de la interdisciplinariedad y los desarrollos hacia lo transdisciplinario en campos como la Salud y la Educación no constituyen un requisito formal para reunir especialistas manteniendo intacta la comodidad teórica individual, ni representan un eclecticismo insostenible. Por el contrario, la aproximación interdisciplinaria expresa la fisura de los paradigmas positivistas tradicionales y la búsqueda de nuevas alternativas epistemológicas. El positivismo instaló el mito cultural de la "Ciencia con mayúscula": un Saber Racional absoluto, preconstruido a la acción, neutro, desapasionado y desprovisto de ideologías que prometió el bienestar social a cambio de aceptar mansamente que el conocimiento pertenece exclusivamente a los técnicos. En este proceso, la ciencia positiva funcionó explícitamente como una "Razón de Poder", ignorando que, como lo señalara Paul Feyerabend, la ciencia comete errores con la misma frecuencia que el saber común y que la capacidad de un modelo para producir efectos esperables no debe confundirse jamás con la confirmación de una Verdad inmutable.

Un obstáculo central para la transformación del conocimiento es el **fetichismo de las disciplinas**, entendido como la tendencia a percibir el recorte y la división de las áreas científicas como hechos "naturales" e inmutables. Este fetichismo es especialmente evidente en las ciencias naturales, las cuales aparentan sostener una referencia real e inobjetable en la delimitación de sus objetos, aunque en la práctica atraviesan niveles de incertidumbre similares a las ciencias humanas, tal como lo demuestran los debates contemporáneos de la biología sobre la definición de la vida o las polémicas de la física sobre la materia. Toda ciencia es una construcción humana e histórica cuyos orígenes suelen responder a demandas sociales de dominación que posteriormente son veladas, como ocurrió con el nacimiento de la antropología ligada a las necesidades del imperio colonial frente a las poblaciones denominadas "primitivas". Cuestionar el modelo tradicional de ciencia implica desnaturalizar la categorización vigente de las disciplinas, reconociendo que las divisiones creadas para responder a una determinada demanda histórica resultan inútiles para los desafíos del presente.

La interdisciplina nace, con precisión, de **la indisciplina de los problemas** de la realidad contemporánea. Las problemáticas complejas de la sociedad —amplificadas en el territorio cultural y social de América Latina— no se presentan en el campo de la práctica como objetos puros o delimitados, sino como demandas difusas, contradictorias e interconectadas que desbordan los casilleros unidisciplinarios. Esta realidad exige un pasaje paradigmático: desplazar la

concepción de una Ciencia poseedora de un objeto y un método estáticos hacia la articulación de **campos conceptuales** organizados en torno a prácticas sociales y situaciones-problema concretas. Las corrientes no-positivistas demuestran que es posible construir el conocimiento desde otros supuestos: el constructivismo enseña que el sujeto y el objeto se construyen dialécticamente en la acción, el materialismo dialéctico demuestra que se llega a lo concreto por el camino de lo abstracto y el psicoanálisis descentra la conciencia al afirmar que se piensa allí donde no se es.

Frente a la rigidez de las estructuras académicas, se vuelve indispensable asumir una **actitud indisciplinada e irreverente** ante la Ciencia constituida para poder desarrollar la ciencia en función de las necesidades sociales. La relación de los profesionales con las teorías es siempre pasional, existiendo el riesgo de someterse a ellas o utilizarlas como refugios dogmáticos para evitar el conflicto. La irreverencia propuesta no significa el rechazo o la negación del conocimiento acumulado, sino el rechazo de la veneración acrítica; consiste en la disposición ética y epistemológica de no reverenciar las teorías, sino desafiarlas, interrogarlas y ponerlas a trabajar colectivamente para resolver las demandas complejas de la realidad.

U1.04. Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

04. **Stolkiner, A.** "El enfoque interdisciplinario en el campo de la salud".

RESUMEN DETALLADO.

El enfoque interdisciplinario en el campo de la salud y la salud mental no constituye una teoría unívoca ni un mero ensamblaje técnico de especialidades, sino un **posicionamiento epistemológico, técnico y político de carácter pospositivista**. Este abordaje emerge de la «indisciplina de los problemas» contemporáneos, entendidos como demandas complejas, difusas y contradictorias que desbordan los casilleros disciplinares unívocos. Desde la perspectiva de los sistemas complejos formulada por Rolando García, la interdisciplina rechaza la homologación del objeto de conocimiento con el objeto real, renuncia a las explicaciones causales lineales e integra la historicidad y la incompletud intrínseca de los saberes científicos. Asimismo, al asumir que la producción teórica está ineludiblemente atravesada por sujetos, el enfoque interdisciplinario relativiza la objetividad positivista, incorporando dentro del proceso de conocimiento una dimensión ética y política que exige la acción cooperativa entre los actores sanitarios y comunitarios.

En la sociedad contemporánea, el desarrollo de las prácticas de salud mental se encuentra atravesado por el proceso de **biomedicalización**, una mutación de la medicalización tradicional donde la expansión diagnóstica estatal es acelerada por la irrupción del complejo médico-industrial-financiero. La biomedicalización, tal como la definen Alicia Iriart y Claudia Ríos, implica la internalización del autodisciplinamiento y la autovigilancia de "riesgos" por parte de los propios individuos, convirtiendo a la salud en la nueva moral de la época. Este fenómeno se articula con la mercantilización de la salud y con el **disease mongering** o creación de enfermedades, una estrategia corporativa ejemplificada en revisiones nosográficas como el DSM-5, donde se dilatan las categorías diagnósticas mediante conceptos ambiguos como "espectro" o la patologización del dolor en el duelo. Estas dinámicas consolidan el **Modelo Médico Hegemónico** conceptualizado por Eduardo Menéndez, cuyo rasgo estructural dominante es el reduccionismo biologista: un mecanismo de poder que subordina ideológicamente las dimensiones sociales e históricas del padecimiento, garantizando la cientificidad asimétrica del profesional médico y promoviendo el consumo inducido de psicofármacos.

Como contrapartida y analizador institucional de estas tensiones, la **Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 de la Argentina** representa un hito fundado en la perspectiva de derechos humanos y en las recomendaciones internacionales sobre determinantes sociales de la salud (tales como la Observación General N° 14 del

Comité DESC de Naciones Unidas). La ley define la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos vinculados a la concreción de derechos, desmantelando la lógica segregatoria del paradigma manicomial. Para materializar esta concepción amplia, la norma encomienda la atención a un **equipo interdisciplinario** (integrado por profesionales de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y áreas afines), estableciendo que los graduados universitarios se encuentran en igualdad de condiciones para ocupar cargos de gestión y conducción. Asimismo, en materia de internaciones involuntarias, la ley exige la evaluación integral y firma de al menos dos profesionales del equipo —de los cuales uno debe ser psicólogo o psiquiatra—, sustituyendo la antigua noción de "peligrosidad" potencial por el criterio restrictivo de "riesgo cierto e inminente" para resguardar la libertad y la dignidad de las personas.

La implementación de la Ley N° 26.657 desató una intensa resistencia por parte de corporaciones médicas y facultades universitarias tradicionales, cuya oposición se orientó a neutralizar la horizontalidad de las prácticas. Este discurso corporativo procuró reducir el abordaje interdisciplinario a una "multidisciplina subordinada" o "multireduccionismo", exigiendo que el diagnóstico final continuara restringido a clasificaciones psiquiátricas individuales y convalidado exclusivamente por la firma médica. Esta disputa técnica reitera el afán de reestablecer la jerarquía del Modelo Médico Hegemónico y la centralidad de la prescripción farmacológica, obturando la confluencia de otros campos disciplinares. Por el contrario, la auténtica interdisciplina democratiza la práctica sanitaria al abrir el espacio a **saberes no disciplinarios**, garantizando la participación activa de usuarios y familiares en los órganos de revisión y en los consejos consultivos, e incorporando las pautas tradicionales de las comunidades. En última instancia, el enfoque interdisciplinario articulado a los derechos humanos constituye una herramienta política contrahegemónica que desplaza la atención desde la ontología de la enfermedad hacia la persona como sujeto pleno de derecho.

Teóricos y Prácticos. “Salud Pública y Mental” Cát.: TAJER.

Rep. Arg. (201) Ley 26.657, Ley Nacional de Salud Mental. Derecho a la Protección de la Salud Mental. Decreto Reglamentario 603/2013, **Capítulo V**.

Recuperado el 27 de octubre de 2015.

La reglamentación del Capítulo V del Decreto 603/2013, correspondiente a la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, consolida el cambio de paradigma en el sistema sanitario argentino al establecer un modelo de abordaje integral, interdisciplinario y con base comunitaria. Este marco normativo busca desmontar las lógicas asilares e institucionalizantes, organizando la atención en torno a la dignidad del usuario y la preservación de sus lazos sociales. Para ello, el texto instituye que los equipos asistenciales deben ser de carácter interdisciplinario — conformados de manera no taxativa por profesionales de la psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y otras disciplinas afines—, donde cada integrante asume responsabilidades según sus incumbencias específicas dentro de un esquema de trabajo horizontal y cooperativo. Asimismo, se delega en cada jurisdicción la conformación de estos equipos según sus realidades sociodemográficas y se encomienda a la Autoridad de Aplicación la capacitación continua, la regularización de acreditaciones y la optimización de los recursos existentes para evitar derivaciones fuera del entorno comunitario del paciente.

El modelo asistencial propuesto se rige por directrices fundamentales que priorizan la proximidad geográfica de los servicios al lugar de residencia de la persona, garantizando la continuidad de los tratamientos en los dispositivos que resulten más adecuados y respondan a su preferencia. Este enfoque territorial integra de manera estratégica a los equipos de Atención Primaria de la Salud (APS) —médicos generalistas, enfermeros y agentes comunitarios— y promueve la participación activa de los propios usuarios, sus redes familiares y las organizaciones locales. A su vez, se exige el respeto irrestricto por las diversas identidades colectivas, étnicas, culturales, religiosas, sexuales y de género de la población atendida. Reconociendo que el padecimiento mental está atravesado por factores socioeconómicos, el decreto establece la obligatoriedad de articular políticas intersectoriales que adapten programas estatales de empleo, educación, arte, cultura, deporte y hábitat, herramientas indispensables para asegurar una inclusión social efectiva e impedir la marginación.

En lo concerniente a la autonomía del paciente, la norma ratifica la primacía del consentimiento informado bajo los estándares de la Ley N.º 26.529 de Derechos del Paciente, entendido como el acto formal y libre mediante el cual una persona acepta o rechaza una práctica de salud luego de haber recibido información clara, completa y comprensible. Con el propósito de garantizar la plena accesibilidad

comunicacional, se dispone que, si para recabar dicha voluntad fue necesario implementar recursos especiales, lenguajes adaptados o tecnologías de apoyo para personas con dificultades en la comunicación, tales circunstancias y herramientas deben quedar fehacientemente documentadas en la historia clínica.

Para materializar este esquema en el territorio, el decreto faculta el desarrollo de una amplia red de servicios y dispositivos sustitutivos al hospital monovalente tradicional. Esta red comprende desde centros de atención primaria, servicios de salud mental con internación integrados en hospitales generales y dispositivos de urgencia, hasta centros de rehabilitación psicosocial diurnos y nocturnos, sistemas de apoyo domiciliario y dispositivos habitacionales y sociolaborales con apoyos graduados. Con el fin de evitar que las falencias socioeconómicas deriven en internaciones crónicas encubiertas, la reglamentación prohíbe de forma taxativa la utilización de dispositivos terapéuticos de alojamiento para personas cuya problemática sea de carácter exclusivamente habitacional. Por otra parte, se incluyen formalmente las estrategias de «reducción de daños» —enfoque sanitario destinado a minimizar los riesgos e impactos negativos sobre la salud derivados del consumo problemático de sustancias, sin exigir necesariamente la abstinencia inmediata— y se exige la integración obligatoria dentro de los dispositivos comunitarios a las personas declaradas inimputables por el artículo 34, inciso 1, del Código Penal o aquellas privadas de su libertad bajo procesos judiciales, garantizando además el suministro estatal ininterrumpido de insumos y psicofármacos.

Finalmente, el decreto regula el uso racional de la medicación psicofarmacológica y de cualquier otra intervención terapéutica, supeditando su aplicación a consensos médicos internacionales y a su estricta inclusión dentro de un plan interdisciplinario personalizado. La prescripción y renovación de psicofármacos queda restringida con exclusividad a evaluaciones clínicas efectivas, directas y fundadas, realizadas por médicos psiquiatras o especialistas habilitados, asegurando que la terapéutica farmacológica sea concebida como un recurso complementario y no como un mecanismo punitivo o de contención asilar.

Teóricos y Prácticos. “Salud Pública y Mental” Cát.: TAJER.

Tajer, D., Luciani Conde (...). “Estado, políticas sociales, salud colectiva y salud mental.”

Débora Tajer y su equipo analizan la articulación estructural entre las transformaciones sociohistóricas del Estado moderno occidental, los modelos de políticas sociales y las respuestas institucionales en los campos de la salud colectiva y la salud mental. Para abordar esta problemática, el texto propone un esquema operativo que distingue tres dimensiones constitutivas de lo estatal: la dimensión relacional, que define al Estado como una relación social de dominación que institucionaliza asimetrías políticas, económicas y culturales mediante el monopolio simultáneo de la coacción y la búsqueda de legitimación o consenso; la dimensión institucional u objetivaciones del Estado, conformada por el aparato burocrático y las instituciones visibles a través de las cuales las personas experimentan la presencia estatal; y los procesos de producción de subjetividad o subjetivaciones, entendidos, en los términos de Suely Rolnik, como aquellas representaciones imaginarias y modos de existencia de época —tales como la figura del individuo concebido como cliente o consumidor— que otorgan consistencia existencial y sostienen a un régimen sociopolítico determinado.

A partir de esta matriz conceptual, los autores examinan la tensión permanente entre el Estado y el mercado a lo largo de los ciclos del capital, diferenciando los momentos procíclicos de aquellos contracíclicos. En los momentos procíclicos —correspondientes a los modelos de Estado liberal, neoliberal y el emergente anarcocapitalismo— rige la premisa de la autorregulación mercantil y el repliegue hacia un Estado mínimo. Esto promueve la mercantilización de la vida, concepto formulado por Gøsta Esping-Andersen para describir la conversión de las personas, su fuerza de trabajo y los bienes sociales en meras mercancías sujetas a la lógica de la oferta y la demanda, donde la intervención pública queda reducida a una asistencia residual y focalizada para la población comprobadamente indigente. Por el contrario, en los momentos contracíclicos —representados por el Estado de Bienestar keynesiano de mediados del siglo XX y los proyectos posneoliberales de comienzos del siglo XXI— el Estado interviene activamente en la regulación económica y promueve procesos de desmercantilización, garantizando el acceso a bienes esenciales como salud, educación y previsión social en tanto derechos inherentes a la condición de ciudadanía, sustrayéndolos del imperativo del lucro.

El despliegue de las reformas neoliberales consolidadas en América Latina durante la década de 1990 bajo el Consenso de Washington transformó profundamente los sistemas sanitarios. A diferencia de los países centrales, donde la desregulación financiera coexistió con el sostenimiento de sistemas universales de bienestar, en

los países periféricos se desreguló tanto la economía como la provisión de bienes sociales. En el caso argentino, este proceso no derivó en una privatización total, pero introdujo profundas asimetrías: se produjo una descentralización de la atención primaria hacia los municipios sin financiamiento garantizado, se tercerizaron servicios generales y se desregularon las obras sociales sindicales, permitiendo el ingreso de las empresas de medicina prepaga. Estas últimas captaron los aportes obligatorios de los sectores con mayores ingresos y menor riesgo epidemiológico, fenómeno conocido como desceme, que desfinanció al sistema solidario al dejar en él a los trabajadores de menores recursos y a las personas con enfermedades preexistentes. Asimismo, la instauración del Plan Médico Obligatorio (PMO) como un paquete mínimo de prestaciones fragmentó la integralidad del cuidado e impuso la primacía del criterio de eficiencia —entendido como la maximización de la cantidad de prestaciones en el menor tiempo posible, sintetizado en el modelo de la consulta de quince minutos funcional a la industria farmacéutica— por sobre el criterio de eficacia resolutoria de los problemas de salud.

Frente a la crisis del modelo neoliberal a comienzos del siglo XXI, se produjo en Argentina un giro posneoliberal que recuperó la capacidad regulatoria del Estado y expandió la agenda de derechos sociales mediante programas como REMEDIAR y SUMAR, junto con normativas como las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género. En este marco, y apoyándose en los desarrollos teóricos de Alicia Stolkiner y Mario Rovere, el texto concibe a la salud no como un bien de consumo o un acto técnico aislado, sino como un proceso histórico, social y político atravesado por relaciones de poder. Como parte de esta ampliación de derechos, la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en 2006 se constituye en una política pública fundamental frente a la mercantilización de los vínculos afectivos y las juventudes. Desde los aportes de Débora Tajer sobre la Organización Social del Cuidado —categoría que visibiliza que las tareas de cuidado no pertenecen a la esfera privada o exclusivamente femenina, sino que expresan relaciones de poder y responsabilidades públicas indelegables—, la ESI interviene sobre la trama vincular para desarticular los mandatos de éxito individual y competencia, habilitando espacios de escucha, reconocimiento de la alteridad y cuidado colectivo.

Este recorrido sociohistórico encuentra un correlato directo en las transformaciones del campo de la salud mental. Desde el advenimiento del alienismo tras la Revolución Francesa, el Estado moderno consolidó una alianza entre la psiquiatría y el aparato jurídico-penal que asoció la locura con la noción de peligrosidad, legitimando el asilo, el encierro y la privación de derechos como mecanismos de control social y tutela. Aunque el higienismo de principios del siglo XX incorporó determinantes ambientales, fue recién tras la Segunda Guerra

Mundial, en consonancia con la emergencia de los derechos humanos y los Estados de Bienestar, cuando comenzaron a gestarse modelos comunitarios, tales como la psiquiatría de sector en Francia y la Psiquiatría Democrática impulsada por Franco Basaglia en Italia, que derivaron en la Declaración de Caracas en 1990 y la crítica al modelo hospitalocéntrico. En Argentina, este cambio de paradigma culminó con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 en 2010, la cual consagró la presunción de capacidad jurídica, la interdisciplina, el abordaje comunitario y el carácter excepcional y estrictamente regulado de las internaciones involuntarias en situaciones de riesgo cierto e inminente, incorporando además la atención de los consumos problemáticos bajo un enfoque integral de reducción de daños y trabajo territorial.

No obstante, la implementación efectiva de la Ley 26.657 ha enfrentado persistentes resistencias por parte de corporaciones psiquiátricas tradicionales, instituciones monovalentes privadas y la industria farmacéutica, las cuales ven amenazados modelos de negocio y cuotas de poder históricamente basados en la medicalización y la institucionalización crónica. En la coyuntura contemporánea, caracterizada por la emergencia de discursos anarcocapitalistas, tecnofeudales y políticas de ajuste presupuestario que recortan recursos sanitarios, los autores advierten sobre el riesgo de retroceder hacia modelos tutelares. A través de operaciones mediáticas que difunden la falsa premisa de que la ley prohíbe las internaciones, se intenta reinstalar el criterio de peligrosidad como respuesta simplificada y punitiva frente al malestar subjetivo. El texto concluye señalando que la clínica individual es completamente ineficaz para revertir un sufrimiento psíquico originado en la exclusión estructural, la pobreza, la precarización y la ruptura de los lazos comunitarios —lo que los autores comparan con intentar contener una inundación con un vaso de plástico—, afirmando la necesidad imperiosa de sostener al Estado como garante de derechos y defender la construcción colectiva de los cuidados como único horizonte democrático frente a las políticas de la crueldad.

Teóricos y Prácticos. “Salud Pública y Mental” Cát.: TAJER.

Gastão Wagner de Sousa Campos. *“Desafío epistemológico y práctico: Cómo reformular, ampliando e integrando, la clínica y la salud colectiva (en Método Paideia: análisis y cogestión de colectivos, pp. 184-206.”*

Gastão Wagner de Sousa Campos aborda el desafío epistemológico y práctico de reformular e integrar la clínica y la salud colectiva, dos campos históricamente escindidos en la atención sanitaria. Mientras que la racionalidad clínica se ha centrado predominantemente en la atención individual del episodio agudo y en el ámbito ambulatorio o hospitalario, la salud colectiva ha priorizado el control epidemiológico y las intervenciones poblacionales a nivel macroestructural. Para superar esta fragmentación, el autor propone el Método Paideia —un enfoque conceptual y metodológico inspirado en el ideal formativo griego que busca el desarrollo integral de los sujetos para la vida pública y ciudadana— como una herramienta para propiciar la cogestión del trabajo en salud y la coproducción singular de sujetos, transformando las prácticas hegemónicas mediante la ampliación simultánea de los saberes y la democratización de las instituciones.

El proceso de trabajo en salud es concebido fundamentalmente como un encuentro intersubjetivo mediado por estructuras institucionales, donde convergen actores con distintos saberes, deseos y asimetrías estructurales de poder. Frente a este desequilibrio insalvable entre el profesional portador del conocimiento técnico y el usuario portador de la vivencia de su sufrimiento, la propuesta no radica en desestimar el saber científico, sino en reconfigurar el encuentro como un espacio colectivo y dialógico. Apoyándose en la aplicación que Ricardo Bruno Mendes Gonçalves realizó de las categorías analíticas del trabajo formuladas por Marx, Sousa Campos estructura la reformulación de las prácticas sanitarias a partir de la ampliación de cuatro dimensiones esenciales: el objetivo o finalidad de la acción, el objeto sobre el que se interviene, los medios de trabajo empleados y los resultados producidos.

En cuanto al objetivo ampliado, el autor debate la definición clásica de la Organización Mundial de la Salud que concibe la salud como un estado absoluto de completo bienestar físico, mental y social, calificándola de ideal inalcanzable que invisibiliza los estados intermedios en los que transcurre la vida concreta. En su lugar, y en sintonía con la noción de normatividad vital de Georges Canguilhem, se postula una concepción de salud relativa, evaluada en coeficientes y grados según la singularidad de cada sujeto o grupo poblacional, integrando no solo la extensión cuantitativa de la vida o la prevención de secuelas, sino también la dimensión cualitativa del deseo, el placer y el goce de vivir. Vinculado a este fin, se incorpora de manera central la coproducción de autonomía, entendida no como

una autosuficiencia absoluta o autodeterminación aislada, sino como la capacidad gradual de individuos y colectividades para lidiar con sus dependencias, comprender su contexto y establecer contratos, reglas y compromisos con los intereses y valores de los demás.

Respecto al objeto ampliado, el texto redefine la responsabilidad sanitaria directa o núcleo de responsabilidades del sector salud, diferenciándola del campo general de determinación social donde la intervención es complementaria o intersectorial. El objeto de trabajo no puede reducirse a la enfermedad biológica descontextualizada ni a un sujeto genérico; debe abarcar el proceso de enfermar, los riesgos epidemiológicos y la vulnerabilidad —entendida como el conjunto de factores biológicos, subjetivos, culturales y socioeconómicos que aumentan la susceptibilidad al sufrimiento— encarnados siempre en sujetos singulares, ya sean personas en sus tramas vinculares directas (en la clínica) o colectivos delimitados por territorios y condiciones de vida (en la salud colectiva). Esta inclusión obliga a los profesionales a transitar permanentemente entre las regularidades abstractas de los protocolos diagnósticos y la historia viva de cada caso.

En la esfera de los medios de intervención ampliados, se plantea superar la semiología objetiva tradicional mediante su articulación con la escucha activa de la historia y la demanda del usuario. Esta metodología diagnóstica compartida incluye el análisis de la transferencia y la contratransferencia, conceptos procedentes del psicoanálisis mediante los cuales se explicitan y reelaboran los afectos, expectativas, prejuicios y relaciones de poder que circulan entre trabajadores y usuarios. Asimismo, la intervención terapéutica se despliega a través del denominado Soporte Paideia, un dispositivo que sustituye la prescripción impositiva por la formulación de ofertas técnicas negociadas en espacios dialógicos, abordando núcleos temáticos sobre el contexto social y sobre el mundo interno del sujeto, tales como el análisis de su objeto libidinal —aquello que otorga sentido, valor y motivación singular a su existencia—, sus factores de protección y sus redes de apoyo.

En consonancia con esta perspectiva, la evaluación del resultado ampliado del trabajo sanitario exige trascender la simple medición de metas operativas y se estructura a partir de cuatro dimensiones interrelacionadas: la eficacia en la producción de salud y bienestar; la co-construcción de autonomía en los usuarios; el cumplimiento del principio de no maleficencia o producción del menor daño posible (*primum non nocere*), reconociendo críticamente que toda intervención técnica o discursiva conlleva efectos colaterales, riesgos de dependencia y mecanismos de control social que deben ser atenuados; y, finalmente, la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. La ponderación de estos criterios debe

realizarse de forma dialógica entre los equipos y las comunidades, reconociendo que los juicios evaluativos siempre involucran valores éticos y decisiones políticas.

Para viabilizar esta clínica y salud colectiva ampliadas, Sousa Campos fundamenta la urgencia de transformaciones organizacionales que desmonten la lógica fragmentada, vertical y burocrática de los servicios. Con este fin, se propone la conformación de equipos de referencia interdisciplinarios que garanticen el vínculo longitudinal y la responsabilización sanitaria sobre una población definida, apoyados por el soporte matricial, un dispositivo de retaguardia técnica y pedagógica donde especialistas y generalistas interactúan horizontalmente para personalizar la atención sin romper la continuidad del cuidado. Esta reestructuración se complementa con la elaboración compartida de Proyectos Terapéuticos Singulares (PTS) para casos complejos y la consolidación de colegiados y consejos de gestión democrática, asegurando que la ampliación del poder del usuario, la circulación de la palabra y el respeto a la singularidad orienten de manera efectiva la toma de decisiones y el cotidiano de los servicios de salud.